

Psykiske sygdomme

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Studiecaféerne i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme

Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

2. udgave, Munksgaard

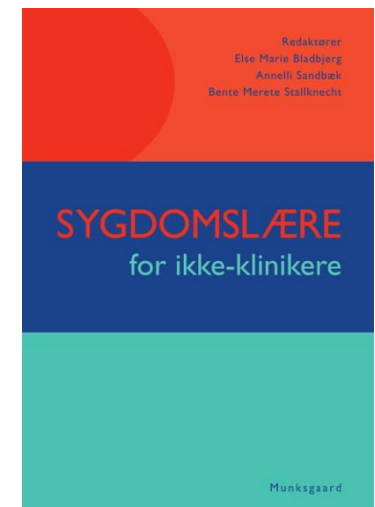
Obs! Hele lærebogen er pensum

+ et kompendium i mikrobiologi (Absalon)

Dagens pensum:

- Kapitel 5 – Psykiske sygdomme (s. 119-173)

Ingen undtagelser!



Dagsorden

■ Psykiske sygdomme generelt

■ Psykosebegrebet

■ Symptomer på psykisk sygdom

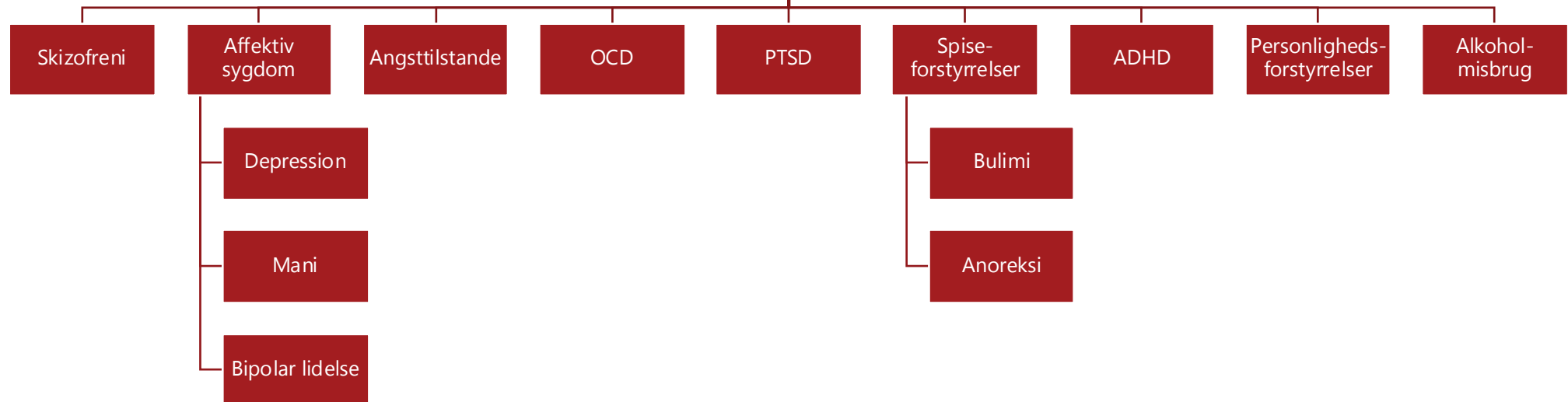
■ Skizofreni

■ Angsttilstande

■ Affektive sygdomme



Psykiske lidelser



Psykiatri



Psykisk sygdom

Neurologi



Sygdomme relateret til nervesystemet

Opgave 1

Generelt om psykiske sygdomme

- Giv dit bedste bud på en definition af psykisk sygdom
- Beskriv generelt ætiologien for psykiske sygdomme
- Forklar psykosebegrebet
- Beskriv ikke-psykotiske symptomer
- Beskriv psykotiske symptomer
- Beskriv kort de generelle principper ved diagnostik og behandling af psykiske sygdomme

Generelt om psykiske sygdomme

Lidelser der påvirker:

- Følelsesliv
- Adfærd
- Kognition (tænkning, planlægning, hukommelse)

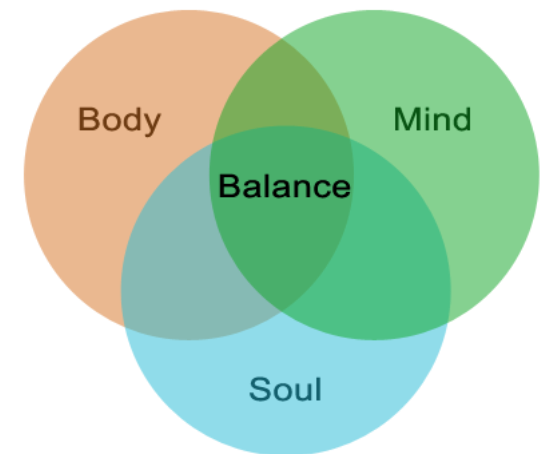
"Sygdom i hjernen"

- Påvirker mentale velbefindende
- Påvirker kropslige processer (psyke og legeme hænger sammen)



OBS! Ikke det samme som psykisk besvær

- Psykisk besvær: Eksamensnervøsitet, tristhed, angst, sorg, bekymring
 - Hører med til et nuanceret menneskeliv
 - Kortvarigt
- Egentlig sygdom:
 - Længerevarende
 - Tilbagevendende symptomer flere gange i livet
 - Betydelig indvirkning på ens funktionsevne (arbejde, familieliv, uddannelse mm.)



WHO's ICD-10 (nu ICD-11): Klassifikationssystem for psykiske sygdomme

Psyisk sygdom

Ætologi:

Key word: *Sammensat / multifaktoriel*

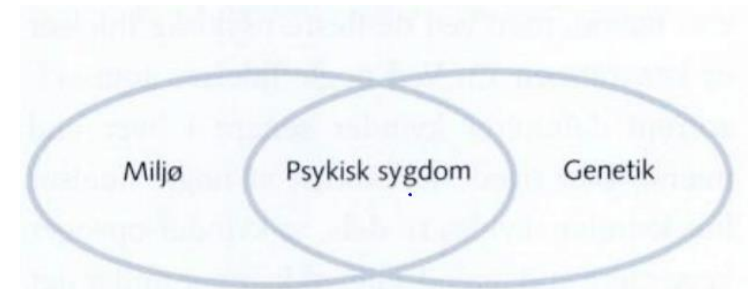
- Komplekst sammenspil af arv og miljø
- Interaktion mellem individet og dets miljø

Genetisk disposition:

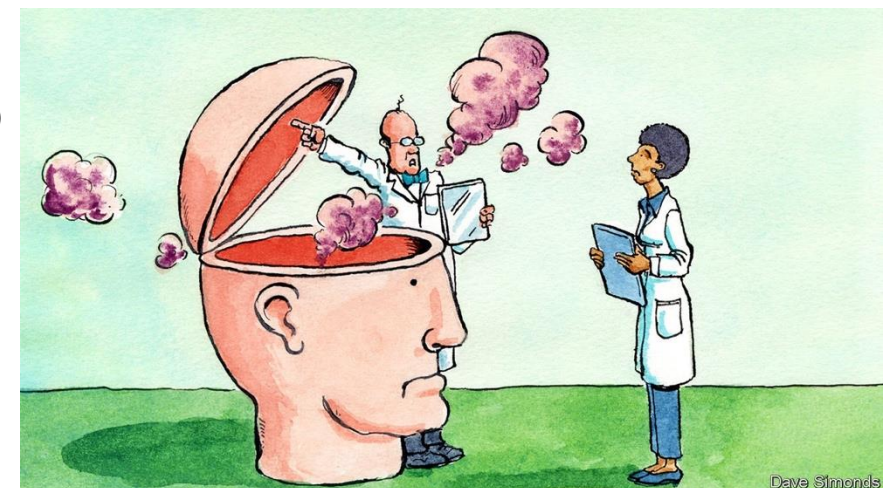
- Man arver en *risiko* for sygdom (mange gener involveret)
- Behøver ikke medføre sygdom
- Sygdom manifesterer sig hos personer der udsættes for specifikke miljøfaktorer

Miljøfaktorer:

- Stressende livsbegivenheder (skilsmisse, afskedigelse, død af nærtstående)
- Misbrug af psykoaktive stoffer
- Prænatale infektioner
- For tidlig fødsel
- Omsorgssvigt i opvæksten
- Sult, fattigdom
- Stigende urbanisering og forurening



Figur 5.1. Forholdet mellem miljø, genetik og psykisk sygdom.



Psykosebegrebet

Psykiatrien Region Sjælland: "En psykisk tilstand, hvor den måde du opfatter virkeligheden på ændrer sig. Psykose påvirker din evne til at tænke, føle og opleve"

- **Realitetstab** (ændret / forvrænget virkelighedsopfattelse)
- Kan komme pludseligt eller udvikle sig langsomt over tid
- Opstår pga. en kombination af biologiske, psykologiske og sociale påvirkninger

Hvornår har man en psykose?

- Kræver en ekspert-vurdering
- Når der viser sig en række typiske psykotiske symptomer = psykotisk
- Man kan godt være psykotisk uden psykotiske symptomer
 - Fx den maniske tilstand hvor stemningsleje og adfærd er så ændret, at personens virkelighedsopfattelse er ændret



Organisk vs. ikke-organisk psykose

Organisk psykose: Skyldes en fysisk sygdom i hjernen, fx et kranietraume, en tumor, demens eller lign.

Ikke-organisk psykose: Skyldes ikke en fysisk sygdom i hjernen

Ikke-psykotiske symptomer

Oplevelsen af "som om" – *det er som om jeg er en robot*

- Patienten ved godt at det er hinsides fornuften og distancerer sig fra oplevelsen
- **Angst:** Reaktion på ydre farer – hjertebanken, sveden, rysten, hyperventilation, kvalme, trykken for brystet, svimmelhed, dødsangst mm.
- **Depressive symptomer:** Tristhed, selvbeprejdelse, søvn- og appetitforstyrrelser, håbløshedsfølelse, energiløshed, følelsestomhed, selvmordstanker mm.
- **Maniske symptomer:** Løftet stemningsleje, øget selvfølelse, stor selvtilid, øget energi- og aktivitetsniveau, springende tankegang, øget libido (sexlyst), vrede, irritabilitet, nedsat søvn
- **Tvangssymptomer:** Obsessioner (tvangstanker) og kompulsioner (tvangshandlinger)
- **Kognitive symptomer:** Problemer med indlæring, hukommelse, planlægning, koncentration, genkendelse
- **Depersonalisationsoplevelser:** Oplevelsen af egen uvirkelighed (*som om* man ikke er sig selv)
- **Derealitetsoplevelser:** Oplevelsen af at omgivelserne er uvirkelige (teateragtigt, kunstigt)



Psykotiske symptomer

Oplevelsen af at det er sådan det er – *jeg er en robot!*

- **Hallucinationer:** Sanseindtryk uden ydre sansestimulus (høre, se, føle, lugte el. smage noget der ikke er der)
 - Hørehallucinationer: "Hører stemmer", musik, trin på trappen, knirken, raslen
 - Synshallucinationer: Syn af genstande/personer som ikke er der eller som skygger/ånder
- **Vrangforestillinger:** "Privat ukorrigerbar idé som ikke deles af andre med samme sociokulturelle baggrund"
 - Personlig/privat – altså ikke religiøs, kulturel eller politisk forestilling
 - Forskellige forestillinger: Selvhenførende, depressive/skyld, forfølgelse, storhed, styringsoplevelser
 - Bizarre vrangforestillinger: Fysisk umulige, fx at pt kan få solen til at gå op og ned (især hos skizofrene)
- **Katatoni:** Kvalitative ændringer i bevægelse
 - Bevægeforstyrrelser med ændret muskelspænding og motorik
 - Fx at kunne sove med hovedet løftet over hovedpuden, stivne kortvarigt, urotilstande, mutisme (stumhed)
 - Fænomenerne er ikke bevidste
- **Tankeforstyrrelser**
 - Subjektive: Tanketomhed, tankepåføring, tankeudspredning – noget pt selv oplever
 - Formelle: Forstyrrelse i tænkningen som det viser sig i sproget – opleves af omgivelserne



Diagnostik og behandling

Diagnostik

- Sker ud fra symptomerne
- Diagnostiske kriterier i ICD-10 er grupper af symptomer, der typisk optræder sammen
- Adgang til symptomerne er **samtale** og **observation** af patienten
- Supplering med psykiske test
- Udelukkelse af somatisk lidelse ved grundig legemlig undersøgelse og parakliniske undersøgelser

Behandling

Tværfaglig disciplin

- Medicinsk behandling
- Psykoterapi
- Støttende samtaler
- Miljøterapi
- Adfærdsterapi
- Psykoedukation
- Fysio- og ergoterapi
- Sociale tiltag

Tabel 5.2. Diagnoser for psykiske lidelser.

Diagnosenumre	Diagnosekategorier
F00-09	Organiske psykiske lidelser
F10-19	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer
F20-29	Skizofreni, skizotypi, paranoide psykoser samt skizoaffektive psykoser
F30-39	Affektive sindslidelser
F40-49	Nervøse og stressrelaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer
F50-59	Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
F60-69	Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd
F70-79	Mental retardering
F80-89	Psykiske udviklingsforstyrrelser
F90-98	Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barn- eller ungdom

Opgave 2

Skizofreni

- Definér skizofreni
- Redegør kort for patogenesen
- Redegør kort for symptomer og fund
- Beskriv kort diagnostikken

Skizofreni

Definition

Psykisk sygdom kendetegnet ved

- Karakteristiske forstyrrelser af tænkning og perception (=oplevelsen af verden gennem sanserne)
- Dårlig afstemt eller manglende eller nedsat følelsesmæssigt engagement (medsving)
- Nedsat social funktionsevne

Patogenese

Der ses en række ændringer i hjernens struktur, dens neurotransmittere og disses receptorer:

- Tab af grå substans (kan ses på CT-scanning)
- Forstyrrelser i informationsbearbejdning, stofskifte og blodgennemstrømning i regionale områder i af hjernen
- Overskud af dopamin i hjernen (forbundet med psykotiske symptomer)

Skizofreni

Symptomer og fund

Meget broget symptombillede, alle psykopatologiske fænomener kan ses. Centralt er de 4 A'er:

- Autisme
- Associationsforstyrrelser
- Ambivalens
- Affektforstyrrelser

Diagnostik

- Grundig anamnese
- Grundig objektiv somatisk og neurologisk undersøgelse
- Blodprøver og evt. scanning af hjernen
- Struktureret diagnostisk interview, fx med brug af spørgeskema
- Psykologisk testning

Skizofreni

Diagnostik

Tabel 5.4. ICD-10-kriterier for skizofreni (F20).

I	1. Mindst et førsterangssymptom (Tabel 5.5) ELLER 2. Vedvarende "bizarre" vrangforestillinger OG/ELLER 3. Mindst to af følgende: a. Dagligt optrædende hallucinationer (uanset hvilken type), ledsaget af vedvarende vrangforestillinger uden tydeligt affektivt indhold b. Svære sproglige (formelle) tankeforstyrrelser c. Kataton adfærd d. "Negative" symptomer (Tabel 5.6)
II	Symptomer skal have været til stede i mindst en måned
III	Organisk ætiologi (årsag) udelukkes

*ved "bizar" forstås fuldstændig umuligt eller kulturelt uacceptabelt.

Tabel 5.5. Skizofrene førsterangssymptomer.

Tankepåvirkningsoplevelser (= subjektive tankeforstyrrelser)
• Tankepåføring • Tankehørighed • Tankeudspredning • Tankefradrag
Styringsoplevelser
• Påførte handlinger • Påførte viljesimpulser • Påførte følelser
Tredjepersons hørelsehøllucinationer
• Kommenterende stemmer • Diskuterende stemmer
Legemlige påvirkningsoplevelser
Primær vrangsansning (= vrangagtige sansninger)

Tabel 5.6. ICD-10-kriterier/negative symptomer.

Symptomer	Træghed Sløvhed Affektaffladning (følelsesaffladning) Initiativløshed Passivitet
Adfærd	Kontaktforringelse Manglende fremdrift Tom eller formålsløs adfærd Indsynken i sig selv Social tilbagetrækning Ensomhedssøgen

Opgave 3

Angsttilstande

- Definér angsttilstand inkl. de typiske symptomer
- Angiv forekomsten af angsttilfælde
- Beskriv kort patogenesen
- Beskriv kort ætiologien
- Beskriv de forskellige typer af angst, herunder symptomer ved de forskellige typer
- Beskriv kort diagnostikken af angsttilstandene
- Redegør kort for behandlingen af angsttilstande

Angsttilstande

Definition: Lidelse hvor patienter udviser både autonome symptomer og andre angstsymptomer

Autonome symptomer	Andre angstsymptomer
1. Hjerterbanken	5. Vejtrækningsbesvær
2. Sveden	6. Kvælningens fornemmelse
3. Rysten	7. Trykken for brystet
4. Mundtørhed	8. Kvalme og uro i maven
	9. Svimmelhed
	10. Uvirkelighedsfølelse
	11. Frygt for at dø
	12. Hedeture eller kuldegysninger
	13. Dødhedsfølelse eller paræstesier
	14. Frygt for at miste selvkontrollen

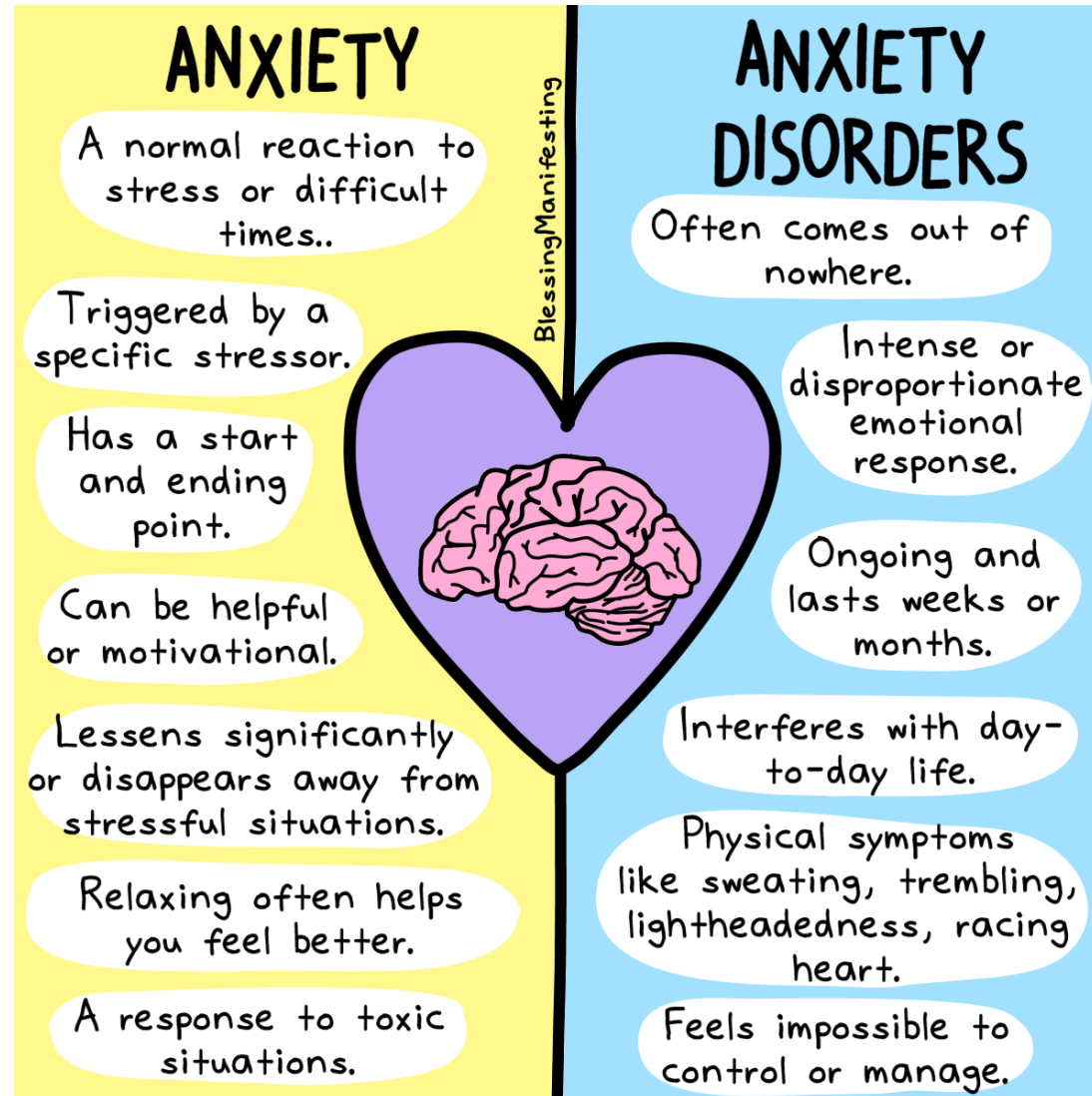
Angsttilstande kan inddeles i:

- Panikangst
- Generaliseret angst
- Fobisk angst

Forekomst

- Prævalens på 2-5% af den voksne danske befolkning
 - Årligt er 150.000 ramt
- Debuterer ofte allerede i barneårene
- Dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd





Angsttilstande

Patogenese:

Aktivering af det limbiske system (inkl. gyrus cinguli)

- Fare → thalamus → visuelt cortex (synsbark) → amygdala
- Den direkte vej: Amygdala → hypothalamus → aktivering af alarmberedskabet
- Den indirekte vej: Amygdala → frontallap → fortolker om der reelt er fare

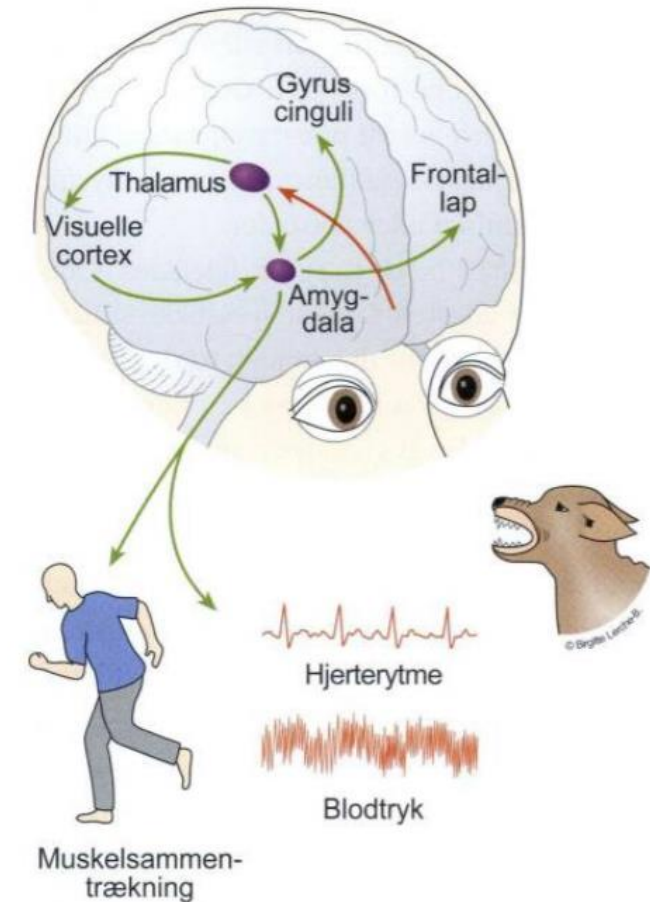
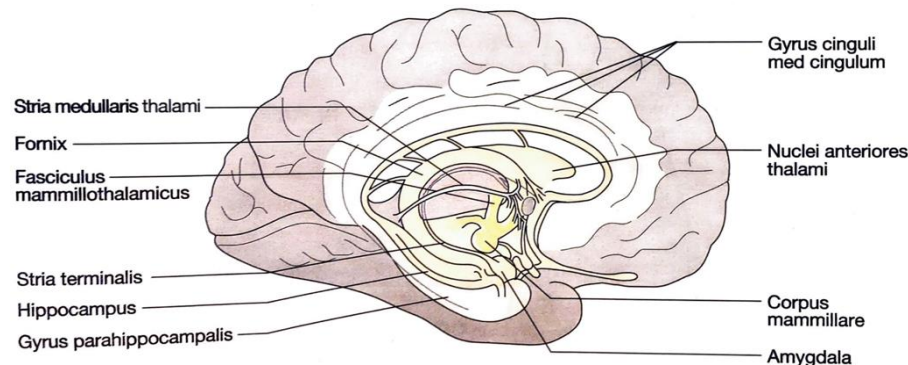
Ubetinget vs. betinget

Ubetinget respons: Farligt stimulus = alarmberedskab

Betinget respons:

Først: Farligt stimulus + neutralt stimulus = alarmberedskab

Senere: Neutralt stimulus = alarmberedskab



Figur 5.3. Joseph E. LeDoux' angstmodel.

Angsttilstande

Ætiologi

Sårbarhed-stress-modellen

- Person med øget sårbarhed (pga. flere **disponerende faktorer**) → person skal udsættes for mindre stressbelastninger (**udløsende faktorer**) før der udvikles angsttilstande
- Person med øget sårbarhed får alvorligere psykiske reaktioner på belastninger

Disponerende faktorer

- Genetiske faktorer (bestemte personlighedsstrukturer oplever oftere angsttilstande)
- Tidligere sociale og psykologiske belastninger (fx omsorgssvigt eller overgreb)

Udløsende faktorer

- Senere belastninger såsom trusler på livet, skilsmisse, arbejdsløshed

Forskellige angsttilstande

Angst → undvigelsesadfærd

Fobisk angst

- Rettet mod konkrete ting eller situationer (som pt derfor gerne vil undgå)
- Erkender at angsten / undgåelse er overdreven eller urimelig
- Eksempler:
 - Agorafobi – angst for menneskemængder, offentlige steder, færden alene, færden uden for eget hjem, offentlig transport
 - Socialfobi – angst for sociale situationer, for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed, præstationsangst
 - Enkeltfobi – angst for specifikke ting: dyr, højder, torden, mørke, flyvning, lukkede rum, tandlæger, visse fødeemner

Tabel 5.12. ICD-10-kriterier for agorafobi (såvel, A, B og C skal være opfyldt).

A. Angst eller undgåelse af > 2 af følgende situationer: 1. menneskemængder 2. offentlige steder 3. færden alene 4. færden uden for eget hjem
B. > 2 angstsymptomer samtidigt, heraf mindst ét autonomt (se Tabel 5.10)
C. Fællestræk for fobiske angsttilstande skal være opfyldt (se Tabel 5.11)

Panikangst

- Pludseligt indsættende angst med flere symptomer samtidig (især hyperventilation, hjertebanken, trykken for brystet)
- Pt er bange for at miste kontrollen over sig selv eller ligefrem at dø – pt søger derfor ofte læge
- Optræder ved mange andre psykiske lidelser (fx depression)

Generaliseret angst

- Mere el. mindre konstant angst (ikke knyttet til bestemte situationer el. anfald)
- Konstant stresspåvirkning → pt er bleg, anspændt og forpint
- Ængstelse og bekymring over dagligdagsting, ofte irritable, støjoverfølsomme, dårlig hukommelse
- Periode > 6 mdr
- Diagnose kan ikke stilles, hvis symptomer optræder som følge af somatisk sygdom eller samtidig med anden psykisk lidelse

Tabel 5.16. ICD-10-kriterier for generaliseret angst (A, B og C skal være opfyldt).

A. Periode på > 6 måneder med anspændthed, bekymringstendens og almen ængstelighed over dagligdags begivenheder og problemer	
B. Mindst fire af nedenstående angst- og spændingssymptomer, heraf mindst ét autonomt:	
Autonome symptomer	Psysiske symptomer
Hjertebanken eller palpitationer	Svimmelhed
Sveden	Uvirkelighedsfølelse
Rysten	Frygt for at blive sindssyg
Mundtørhed	Dødsangst
Symptomer fra bryst og mave	Uspecifikke symptomer
Åndenød eller kvælningss fornemmelse	Koncentrationsbesvær
Trykken for brystet	Irritabilitet
Kvalme eller uro i maven	Indsovningsbesvær
	Tendens til sammenfaren
Almene symptomer	Tensionssymptomer
Varme- eller kuldefølelse	Muskelspænding
Døds- eller sovende fornemmelse	Rastløshed
	Psykisk spændingsfølelse
	Følelse af synkebesvær
C. Organisk ætiologi, psykotisk lidelser, depressiv episode, andre angsttilstande og obsessiv-kompulsiv tilstand udelukkes	

Angsttilstande

Diagnostik

Sker ved diagnostisk interview med afdækning af

- Angstsymptomer
- Kropslige symptomer
- Forekomst af andre psykiske symptomer
 - Især misbrugs- og depressive symptomer
- Vurderes ift. udelukkelse af somatisk lidelse
 - Især hjerte- og stofskiftelidelser

Tabel 5.12. ICD-10-kriterier for agorafobi (såvel, A, B og C skal være opfyldt).

- A. Angst eller undgåelse af > 2 af følgende situationer:
1. menneskemængder
 2. offentlige steder
 3. færden alene
 4. færden uden for eget hjem
- B. > 2 angstsymptomer samtidigt, heraf mindst ét autonomt (se Tabel 5.10)
- C. Fællestræk for fobiske angsttilstande skal være opfyldt (se Tabel 5.11)

Tabel 5.16. ICD-10-kriterier for generaliseret angst (A, B og C skal være opfyldt).

A. Periode på > 6 måneder med anspændthed, bekymringstendens og almen ængstelighed over dagligdags begivenheder og problemer	
B. Mindst fire af nedenstående angst- og spændingssymptomer, heraf mindst ét autonomt:	
Autonome symptomer Hjertebanken eller palpitationer Sveden Rysten Mundtørhed	Psykiske symptomer Svimmelhed Uvirkelighedsfølelse Frygt for at blive sindssyg Dødsangst
Symptomer fra bryst og mave Åndenød eller kvælningss fornemmelse Trykken for brystet Kvalme eller uro i maven	Uspecifikke symptomer Koncentrationsbesvær Irritabilitet Indsovningsbesvær Tendens til sammenfaren
Almene symptomer Varme- eller kuldefølelse Dødsheds- eller sovende fornemmelse	Tensionssymptomer Muskelspænding Rastløshed Psykisk spændingsfølelse Følelse af synkebesvær
C. Organisk ætiologi, psykotisk lidelse, depressiv episode, andre angsttilstande og obsessiv-kompulsiv tilstand udelukkes	

Tabel 5.15. ICD-10-kriterier for panikangst (A, B og C skal være opfyldt).

- A. Panikanfald inden for fire ugers periode med mindst fire af angstsymptomerne (se Tabel 5.10), heraf mindst ét autonomt
- B. Ikke forbundet med en specifik situation eller et specifikt objekt, en reel fare eller fysisk belastning
- C. Ikke forårsaget af anden psykisk lidelse

Angsttilstande

Behandling af angsttilstande:

Eksponeringsterapi

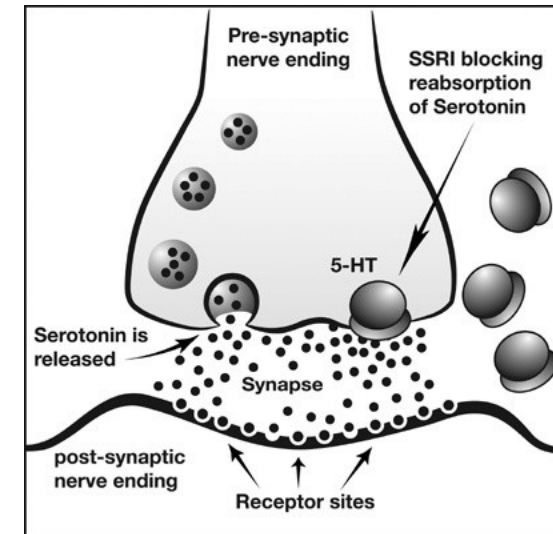
- Pt udsættes gradvist for den fobiske genstand eller situation

Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

- Terapi med fokus på, hvad pt tænker om sig selv og sine vanskeligheder
- Pt korrigeres i sin fejlfortolkning af farligheden af kroppens respons under gradvis eksposering
- Pt's funktionsniveau skal øges gradvis

Farmakologisk/medicinsk behandling

- SSRI-præparater (selektiv serotonin-reuptake-inhibitor, antidepressiva)
- Antiepileptikum – nyt præparat har vist sig at være effektiv især til generaliseret angst
- Benzodiazepiner (beroligende) – symptomlindrende, sløvende og høj risiko for afhængighed
- Betablokker – kortvarigt fx ved eksamen, har ikke sløvende effekt



Opgave 4

Affektive sygdomme

- Hvad er affektive sygdomme? Hvilke findes der?
- Angiv forekomsten af affektiv sygdom inkl. evt. køns- og aldersforskel
- Beskriv kort minimum to hypoteser for patogenesen af de affektive sygdomme
- Redegør for symptomer og fund ved mani
- Angiv behandlingsmuligheder ved mani (i den akutte fase og forebyggende)

Affektive sygdomme

Hvad er det?

Psykiske lidelser, hvor stemningslejet er påvirket i sygelig retning

1. Den unipolare depression
2. Den maniske enkeltepisode
3. Den bipolare affektive sygdom (tidl. *maniodepressiv*)

Unipolar depression:

- Sygdomsepisoderne er alene depressioner
- Enkeltstående eller tilbagevendende episoder

Den maniske enkeltepisode:

- Én solitær episode
- Flere maniske / hypomane episoder → bipolar affektiv sygdom

Bipolar affektiv sygdom

- Min. to affektive episoder hvoraf min. én skal være mani/hypomani/blandingstilstand
- Typisk: Både forekomst af manier og depressioner, evt. også blandingstilstande



Affektive sygdomme

Forekomst

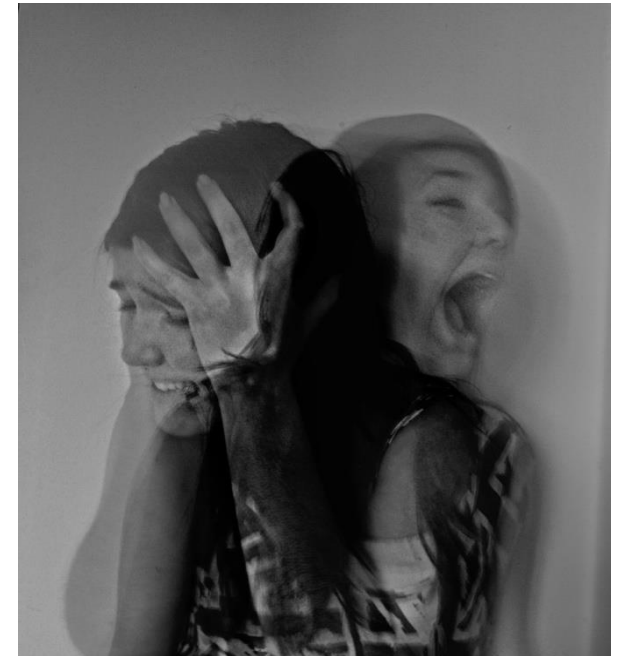
Unipolare depressioner:

- Prævalens: 2-5% af befolkningen i DK (ca. 150.000 personer)
- Årlig incidens: 0,5-1,5% (ca. 50.000 personer)
- Kvinder > mænd (dog ikke i den ældre generation)
- Både unge, voksne og ældre

Bipolar sygdom:

- Prævalens: 1% af befolkningen i DK
- Ingen kønsforskel
- Debuterer klassisk tidligere i livet (20'erne)

10% af alle med første depressive episode vil senere vise sig at være bipolare



Affektive sygdomme

Patogenese

Aminhypotesen

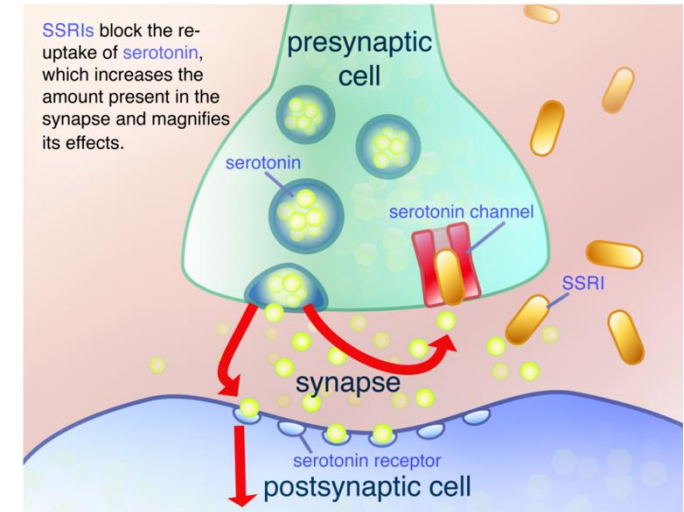
- For lavt niveau af aminer i hjernen (serotonin, noradrenalin, dopamin)
- Ved at øge niveauet kan man behandle det
- Muligvis for højt niveau af dopamin ved maniske tilstande

Hypothalamus-hypofyse-binyrebark-aksen

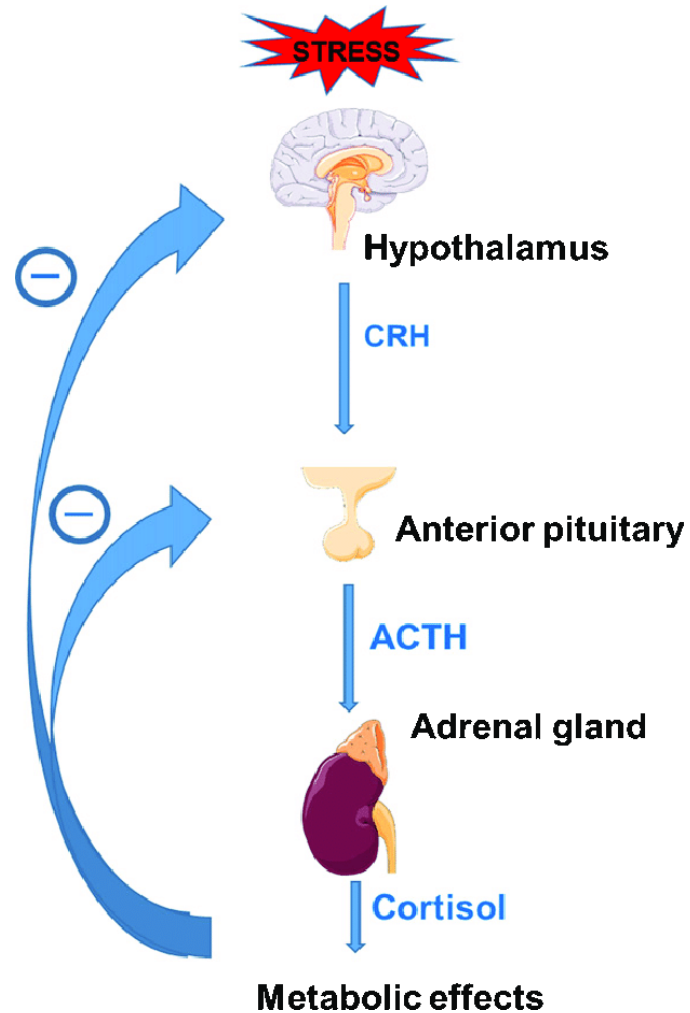
- Stressende situationer → stresshormoner (kortisol, noradrenalin) → stimulerer "fight or flight"-responsen
- Kortvarigt: Omlægning af blodvolumen, fokuseret opmærksomhed, udvidede pupiller mm.
- Langvarigt: Neuronal skade og atrofi, neurondød, atrofi af hippocampus → affektiv sygdom

Kindling og sensitization-hypotesen

- **Gentagne** stressende livsbegivenheder / biologiske stressorer / sociale stressorer
- Fører til udvikling af en affektiv episode med tiden (efter et vist antal begivenheder)
- Sensitization: Mængden af forudgående stressorer aftager med antallet af episoder (pt bliver mere følsom)
- Mindre og mindre stressende begivenheder kan være triggere, mens episoderne stiger i sværhedsgrad



Hypothalamus-hypofyse-binyrebark-aksen



Mani

Symptomer og fund:

- Udvikler sig ofte **hurtigt** (over dage), opstår mere akut end depression
- Kernesymptom: **Det løftede stemningsleje** (voldsom og unaturlig glæde eller ophidselse)
- **Voldsom energi**, igangsætter talrige projekter som ikke gennemføres pga. afledelighed og mangel på fokus
- Tankegangen er springende pga. et **øget associationsniveau**
- **Talepres**: Talen hurtig og præget af de mange hurtige og springende associationer
- Motorisk er pt. meget livlig, i **konstant bevægelse**, kommenterende og konstant talende
- **Eretisme**: Mani præget af vredladenhed, irritabilitet, tendens til at komme i konflikt med alt og alle
- **Øget libido/sexdrift** (kan bringe pt. i stærkt pinlige situationer)
- Voldsomt **pengeforbrug**; kan ofte opnå store lån pga. den energi, entusiasme og veltalenhed vedkommende lægger for dagen → stor gæld
- **Nedsat søvnbehov**: Langvarig mangel på søvn kan bringe pt i en livstruende (delirøs) tilstand
- **Øget selvfølelse**: Kan udvikle sig til megalomane (psykotiske) forestillinger (at være verdens mest intelligente person, ekstremt rig og berømt etc.)
- Evt. **vrangforestillinger** (f.eks. forfølgelsesforestillinger, fordi man er så eftertragtet)



Mani

Tabel 5.9. ICD-10-kriterier for manisk
enkeltepisode.

- A. Opstemthed, eksaltation eller eretisme $\geq$ 1 uge
eller indlæggelse nødvendig
- B. $\geq$ 3 (4 ved eretisk stemning) af følgende med
udtalt påvirkning af dagliglivs-funktioner:
 1. hyperaktivitet, rastløshed, uro
 2. talepres
 3. tankeflugt
 4. hæmningsløs adfærd
 5. nedsat søvnbehov
 6. øget selvfølelse, grandiositet
 7. distraktibilitet eller usamlethed
 8. hensynsløs, uansvarlig adfærd
 9. øget sexdrift
- C. Ingen hallucinationer eller vrangforestillinger
- D. Somatisk ætiologi udelukkes

Mani

Behandling:

Lithium:

- "Stemningsstabiliserende" behandling – nedsætter cellemembranens excitabilitet
- Behandling af den enkelte episode og forebyggende
- Klinisk effekt viser sig dog efter 1-2 uger, så lithium kan suppleres med antipsykotika (sederende)

ECT (elektrokonvulsiv terapi / elektrostimulation):

- Virker mod mani i den akutte fase – "stemningsstabiliserende"
- Pt under generel anæstesi – fremkalder et krampeanfald vha. en elektrisk strøm
- Biokemiske og strukturelle forandringer i hjernen via øgning af aminudbuddet i synapserne
- Dyr: Vækst af nerveudløbere og nydannelse af nerveceller

Samtaleterapi/psykoeducation

- Lærer pt og pårørende at forstå sygdommen, dens konsekvenser og behandlingsmuligheder og opfatte tidlige varsler

Støtte under den maniske episode så ikke patienten bringer sig i kompromitterende situationer

Do you remember?

Hvilken af følgende er ikke en psykisk lidelse?

1. PTSD
2. ADHD
3. PCOS
4. OCD

Hvilken af følgende er ikke et psykotisk symptom?

1. Hallucinationer
2. Tankeforstyrrelser
3. Tvangssymptomer
4. Katatoni

Hvilken af følgende er ikke medicinsk behandling ved angst?

1. Antidepressivum
2. Antikoagulantia
3. Benzodiazepin
4. Antiepileptika

Prævalensen af bipolar sygdom i den danske befolkning er

1. 1%
2. 1,5%
3. 2%
4. 2,5%

Én af følgende er ikke et typisk symptom på mani

1. Øget sexdrift
2. Talepres
3. Selvbeprejdelse
4. Nedsat søvnbehov

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Endokrine sygdomme" i næste modul

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk